



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : شيماء رجب على محمد
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : التبين
رقم البطاقة : 28405080102025 رقم التليفون : 01202780750
العنوان : حلوان
العمر (تاريخ الميلاد) : 08-05-1984 المهنة : بدون عمل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 04-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني + زولاديكس قسم العلاج :
[14165]
الأورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: شيماء رجب علي محمد National ID: 28405080102025	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Plus Goserline
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



موبه فيسبو

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

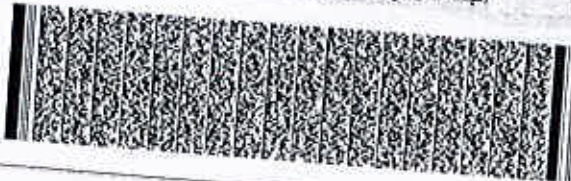


شيماء
رجب على محمد
١٩ ش الحسين - عرب احمد غنيم
الكين - القاهرة

٢٨٤٠٥٠٨٠١٠٢٠٢٥
JY4612268

٢٠٢٣/٠٤ ٢٨٤٠٥٠٨٠١٠٢٠٢٥
حاصله على دبلوم صنايع

مستلمة
انثى
صبيح عياد على ابو الغيط
البطاقة صارية حتى ٢٠٢٥/٠٤/٠٢



للسيستم

هنا

Name:	شيما رجب علي محمد	
MR. :	6004	
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالتها		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها		
The patient is receiving adjuvant therapy with PHESGO and ARAMIDEX, with the regimen scheduled to continue through cycle 12. A new echocardiogram has been requested to assess cardiac function during this treatment period. On 27 February 2026, the patient entered cycle 13 of PHESGO SC combined with ARIMIDEX, with supportive therapy. Echocardiographic evaluation showed an ejection fraction of 61%. On 8 March 2026, ZOLADEX was administered at a dose of 10.8 mg, and the medication was obtained from pharmacy. On 12 July 2026, the patient's left breast cancer was staged as ct4b n1. The tumor was identified as IDC, ER-positive (7/8), PR-positive (7/8), HER2-negative, with recurrence noted on 16 June 2026. A left MRM was performed, and the pathology was ypT0 ypN0/4. A port was placed, and ZOLADEX was continued as an AI from 8 2025. PHESGO was continued through cycle 15, and ZOLADEX was continued. The patient reported bony tenderness in the iliac bone, prompting a bone scan. On 2 August 2026, the patient's ejection fraction was 60% as of 30 July 2026. Fatty liver was noted on imaging. A small breast lesion (BI-RADS 1) was observed on 8 March 2026. The patient was scheduled for cycle 16 of PHESGO SC and ARIMIDEX, with bone scan pending. On 25 August 2026, the patient was scheduled for cycle 17 of PHESGO plus ARIMIDEX with supportive therapy. Follow-up was planned in the oral clinic thereafter.		
تحريرا في ,		
	الوقت :	التاريخ : 20-09-2026
dina makram		الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

Patient Name : الأستاذة / شيماء رجب علي
Patient No. : 28405080102025
Age No. : 4591/24
Sex : Female
Age : 40 Y
Referring Doc :

Request No. : 13009613
Request Date : 24/11/2024
Verification Date : 10/12/2024
Financial Category : أورام دار السلام - مبانجود
Department : Out Patient
Registered by : Mrs. Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data: Left breast 2 O'clock mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 24/11/2024

Gross Examination:
4 grayish white tissue cores up to 1 cm, totally submitted.

Microscopic Examination:
* Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
* Ductal carcinoma in situ: Focal DCIS (intermediate grade, comedo type & solid type).
* Perineural invasion: Not detected.
* Angioinvasion: Not detected.

Diagnosis:
Left breast mass, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma G II with focal DCIS.
For IPT (ER, PR, Her2 and Ki67).

Signature
Prof. Dr. Lubna Omar
Dr. Menna Nabil

Verified by :

Printing Date: 16/12/2024 11:11:41

Page 1 of 1

Printing By : Mrs. Mayada Hegazy



شرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنوش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mizr El Qadema - Cairo, Egypt



Patient Name	: الأستاذة / شيماء رجب على	Request No.	: 13009613
Patient No.	: 28405080102025	Request Date	: 24/11/2024
Path No.	: 4591/24	Verification Date	: 16/12/2024
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مياجره
Age	: 40 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Left breast 2 O'clock mass.

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 24/11/2024.

Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:

ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Results:

IPT (Positive control showed appropriate reactivity):

ER: Strong nuclear reaction in 60% of tumor cells (score 7/8).

PR: Strong nuclear reaction in 50% of tumor cells (score 7/8).

Her2: Strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+).

Ki67: 25% nuclear reaction of tumor cells.

Conclusion:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

Invasive duct carcinoma, with focal DCIS, Grade II.

T:

ER: Positive (score 7/8).

PR: Positive (score 7/8).

Her2: Positive (score +3).

Ki67: Positive in 25% of tumor cells.

Scoring system: "ER, PR"

CO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1,

Verified by :

Printing Date: 16/12/2024 11:11:40

Page 1 of 2

Printed By: Mrs.Mayada Hegazy



Patient Name الأستلاء / شيماء رجب على
Patient No. 28405080102025
Age No. 4591/24
Sex Female
Age 40 Y
Referring Doc.

Request No. 13009613
Request Date 24/11/2024
Verification Date 16/12/2024
Financial Category اوام دار السلام - مبالغه
Department Out Patient

Registered by Mrs. Mayada Hegazy

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

1, between 1% and 10%; 2, between 11% and 33%; 3, between 34% and 66% and 4, between 67% and 100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

Staining system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013. IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor

Signature
Prof. Dr. Lubna Omar
Dr. Menna Nabil

Verified by :

Printing Date: 16/12/2024 11:11:40

Page 2 of 2

Printed By: Mrs. Mayada Hegazy



لوحه رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - أورتونش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor - Building No. 987 - Nile Corniche - Mide El Qadima - Cairo, Egypt



Pat. Name شيماء رجب علي	Study Date 19/02/2025
Pat. ID 42296	Ref. Phy. -----

M.R.I. OF THE ABDOMEN AND PELVIS

Technique:

Abdomen:

- Axial T1, T2 WIs
- Coronal T1, T2 WIs
- Post contrast axial and coronal T1 WIs

Pelvis:

- Axial T1, T2 WIs
- Coronal T1, T2 WIs
- Sagittal T2 WIs
- Post contrast axial, coronal and sagittal T1 WIs

Findings:

- The liver is of normal size and regular outline, with no obvious focal mass lesion of abnormal intensity or dilated biliary radicle.
- Normal MR appearance of the spleen, kidneys, adrenal glands, pancreas, aorta and IVC.
- Normal size, shape and regular outline of the uterine shadow.
- The different layers of the uterine wall show normal thickness and signal pattern, with no focal lesions detected.
- Both adnexal shadows are free with no definite sizable ovarian cysts or other masses.
- The other pelvic organs appear within normal.
- No significant lymph node enlargement.
- No ascites.

CONCLUSION:

- Essentially normal M.R.I. study of the abdomen and pelvis.

Consultant Radiologist,

DR. MOHAMED FAROUK
DR. HESHAM M. ABDEL-TAWWAB

DR. ABDEL-HAMEED MOHAMED

تقاطع شارع مصر وشارع الدمام بجدة

ت. ١٤٥٠ - ٢٢١٨ - ١٤٤٠ - ٢٢١٨ - ١٤٤٠ - ٢٢١٨ - ١٤٤٠

International Radiology Center



Preventive Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الوقائي للصحة النسائية
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name : شيماء رجب علي محمد

Sex:

3- Medical numbers:

Female

83249697

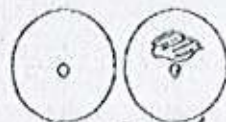
Old Med:

Old Med:

4411-2024

2- ID number:

Patient Age: 41 Y



Family history:

Family history:

Phone:

Phone:

01202760250

BMI:

BMI:

26

REASON OF MDT:

REASON OF MDT:

NEW

Marital status:

Marital status:

BRS Score:

BRS Score:

1

GROUP:

GROUP:

C

Date of MDT:

Date of MDT:

06/01/2025 ☐

Comorbidity:

Comorbidity:

Menopausal status:

Menopausal status:

PERIMENOPAUSAL

Initial STAGE:

Initial STAGE:

PERIMENOPAUSAL
rheumatoid
arthritis,
RHEUMATIC
HEART, HX

Clinical data

Breast Imaging:

lt breast mass UOQ bet 12-3 o'clock reaching the nipple & skin
7x12 cm with overlying suspicious pleomorphic microcalcification
multiple pathological level 1 axillary LN

Mets Workup:

PAUS:free
CYCAP FREE

BX

ER

PR

Her 2 Neu

SISH

Ki67

IDC

7/8

7/8

3

25

EX-SPECIMEN
gill with focal dcis

EX-SPECIMEN

EX-SPECIMEN

EX-SPECIMEN

EX-SPECIMEN

T
CT4B

N
1

M
O BY CT

Sonomanimography

PATIENT HISTORY

ECHO, LABS

BONE SCAN

CLIP INSERTION

+ punch biopsy

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

NACT TCHPX18 WEEKS FOLLOWED BY SURGERY ACC TO RESPONSE

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

MEDICAL ONCOLOGY

RADIOLOGY

RADIOLOGY

SURGERY

SURGERY

PATHOLOGY

PATHOLOGY

Psychiatric

Psychiatric

Nutrition

Nutrition



PP

وزارة الصحة والداخلية
إمارة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام

Echo report

Name: سيف الدين علي
Date: 29/5/2025

Age:

EF	64%	54-74%	PWT	0.9	0.6-1.1cm
LVEDD	4.8	3.5-5.7cm	AO	3.4	2.0-3.7cm
LVESD	2.7	2.2-4.0cm	LA	3.6	1.9-4.0cm
FS	31%	25-45%	RV		0.7-2.3cm (supine)
SWT	1.07	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV dimensions: NLV wall thickness: NLV diastolic function: DD GT.SWMA. NO SWMA at restLA size NAortic root dimension NMitral Valve NAortic valve NTricuspid valve NPulmonary valve NRight side size and systolic function NIntracardiac masses and thrombi NOPericardium NIVC diameter and collapsibility. N

Conclusion:

Mild TR

D/Mohamed Ali

اسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

جوستاف
زوسني
المرشدة - دوال

تقرير طبي

المريد/

تحية طيبة وبعد،،

إيماء للطلاب المقدم من بشأن تقرير طبي للمريض: سيار حبيب

رقم طبي:

ننشر ف بأن نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته:

تاريخ وساعة الدخول: تاريخ وساعة الخروج:

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه:

المريض يعاني من مرض غير جسيم بالشيء وحسب إلى أن حالته
تاريخ مرضه في وقتنا هذا أن المرض ليس له 17 حصة

وتبين له عدة ملاحظة

1	13-8-2015	1	11-3-2015
2	3-9-2015	2	15-4-2015
3	14-9-2015	3	8-5-2015
4	27-10-2015	4	29-5-2015
5	17-11-2015		
6	8-12-2015		
7	15-1-2016		
8	6-2-2016		
9	27-2-2016		
10	11-5-2016		
11	17-7-2016		
12	2-8-2016		

حرجنا في هذا الأمر

تحريرا في

التاريخ: / /

الوقت:

الطبيب المعالج:

يختم:

وتنقلنا إلى أن حالته الآن الجيدة رقت إلى

د. سحر الكمال

4-10-2016

Name : Shaima Ragab Ali Mohammed

Date : 26-09-2026 12:52

Branch : Dokki

Medical No. : 470297

Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt

Tc-99m MDP FOLLOW UP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History

42 year-old female patient with history of treated left breast cancer and referred for follow up.

Technique

Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of 20 mCi of the tracer.

Findings

Considering the last bone scan report dated 27/1/2025, the current scan revealed uniform radiotracer distribution is noted all over the surveyed skeleton with no evidence of abnormal focal active or cold osseous lesion that would account for bone secondaries.
Osteoarthritic features are noticed around big joints.

IMPRESSION

The skeleton is keeping free from osseous metastasis .

Much obliged

Dr. Alaa Nagy, MD,
Nuclear medicine